10. EL CORAZÓN : DESARROLLO DE LA ANATOMÍA ARTERIAL

DURACIÓN : 04:14 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo profundiza en el desarrollo embrionario de las células sanguíneas, describiendo su origen desde la vesícula umbilical hasta la médula ósea. También se explora la persistencia de la arteria mesentérica, un vestigio vital de este proceso, y su papel en el desarrollo intestinal. El arco aórtico se destaca para ilustrar el movimiento rítmico del corazón y su impacto en la circulación sanguínea. Al asociar la dinámica cardíaca con el entorno fascial que mantiene estructuras vitales como el esófago y los bronquios, el vídeo revela cómo los desequilibrios en esta zona rítmica pueden influir en patologías cardiológicas y musculoesqueléticas. Una lección esencial para cualquier terapeuta interesado en las interconexiones corporales.

EL CORAZÓN: DESARROLLO DE LA ANATOMÍA ARTERIAL

ORIGEN Y DESARROLLO DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS

Las primeras **células sanguíneas** aparecen alrededor del **día 18** del desarrollo embrionario. Su origen se sitúa en tres etapas importantes.

Inicialmente, provienen de la **vesícula umbilical**, donde se encuentran los **megaloblastos primitivos**. Esta fase dura los dos primeros meses.

Desde el comienzo del **segundo mes**, un segundo movimiento de producción sanguínea emerge a partir del **hígado**.

Es solo alrededor del **tercer mes** cuando una parte de esta producción comienza a realizarse a nivel de la **médula ósea**.

Aquí se puede observar un desarrollo de la periferia hacia el centro: primero el período **umbilico-pedicular**, luego el período **hepático**, y finalmente la médula ósea para los **glóbulos rojos**.

EL VESTIGIO DEL DESARROLLO VITELINO: LA ARTERIA MESENTÉRICA

El único vestigio que quedará de este desarrollo vitelino es la **arteria mesentérica**.

Servía como eje de rotación, un **fulcro**, para la rotación y el desarrollo del **asa intestinal**.

En el momento en que la **cavidad amniótica** se forma a su alrededor, la vesícula vitelina, que contiene las células originales para la circulación, se reintegra.

Por una parte, con la vesícula vitelina, el **pedículo embrionario** formará el **colon umbilical** con la placenta. El vestigio que se conectará es el **sistema mesentérico** (la vesícula superior). Este eje de rotación es crucial para el desarrollo embrionario.

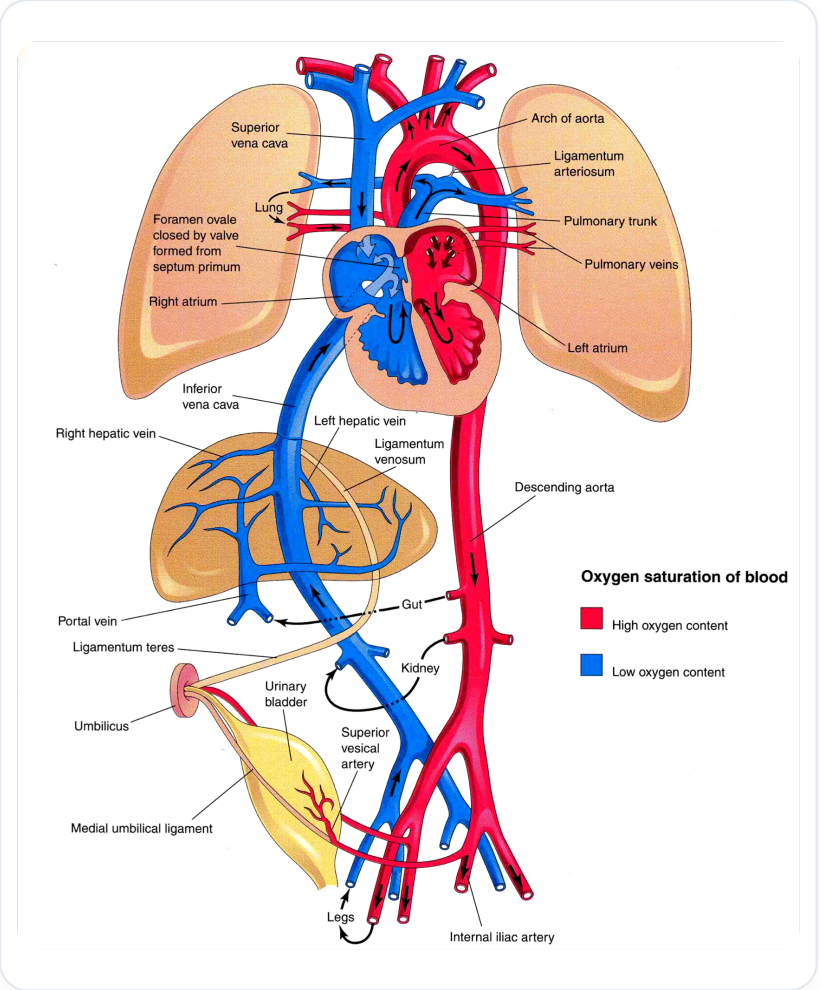


FIG. — Circulación fetal humana

EL MOVIMIENTO DEL CORAZÓN Y DEL CAYADO AÓRTICO

Cuando observamos el corazón, vemos el **cayado de la aorta**. Simbólicamente, podemos decir que sube o baja.

Este movimiento del cayado aórtico representa el **latido del corazón**. Reproduce casi un movimiento de desarrollo.

El cayado de la aorta realiza un movimiento de **torsión** o **destorsión** durante el ciclo cardíaco.

En el momento en que el corazón empuja, el cayado de la aorta se abre para absorber la sangre. En el momento en que el corazón se vacía, se cierra realizando un movimiento particular.

Se abre para tomar la sangre y se cierra para eyectarla, lo que conecta intrínsecamente el cayado de la aorta con la función del corazón.

EL CAYADO AÓRTICO Y EL CICLO CARDÍACO

Es un poco como un jugador de **baloncesto**. En el momento en que el corazón sube, es cuando la aorta eyecta su volumen sanguíneo.

Hay que saber que la aorta contiene en su volumen sanguíneo casi tanta sangre como el corazón a nivel arterial.

Esto significa que la aorta participa activamente en la **eyección sistólica** de la sangre.

Esto está sostenido por el **entorno fascial**, que podríamos comparar con una **"fishnet stocking"** (media de red).

LA ZONA RÍTMICA: UN CRUCE FASCIAL VITAL

El cayado de la aorta, la **bifurcación bronquial** y el **esófago** están conectados por una **fascia** común, lo que los mantiene unidos.

Esta zona, caracterizada por la bifurcación bronquial, es lo que se llama el **punto de la zona rítmica**.

Considere los ritmos vitales: **100.000 latidos cardíacos** en 24 horas, **23.000 respiraciones** en 24 horas y **1.000 a 2.000 degluciones**.

Es una gran zona rítmica que se une y se adhiere entre **D3**, **D4** y **D5**. Estas vértebras forman un plano de equilibrio fascial para la zona rítmica, que es a la vez **cardíaca**, **pleural** y **digestiva**.

Tenemos la aorta, el corazón, y abajo, una bifurcación muy importante: las **arterias ilíacas**. Arriba, hay otro nivel.

De hecho, todo esto forma un plano unitario y puro. Se observa que ciertas patologías de tipo **coxofemoral** u otras pueden desestabilizar el corazón. Inversamente, lo que ocurre en estas fases de rotación puede manifestarse hasta el nivel del corazón.

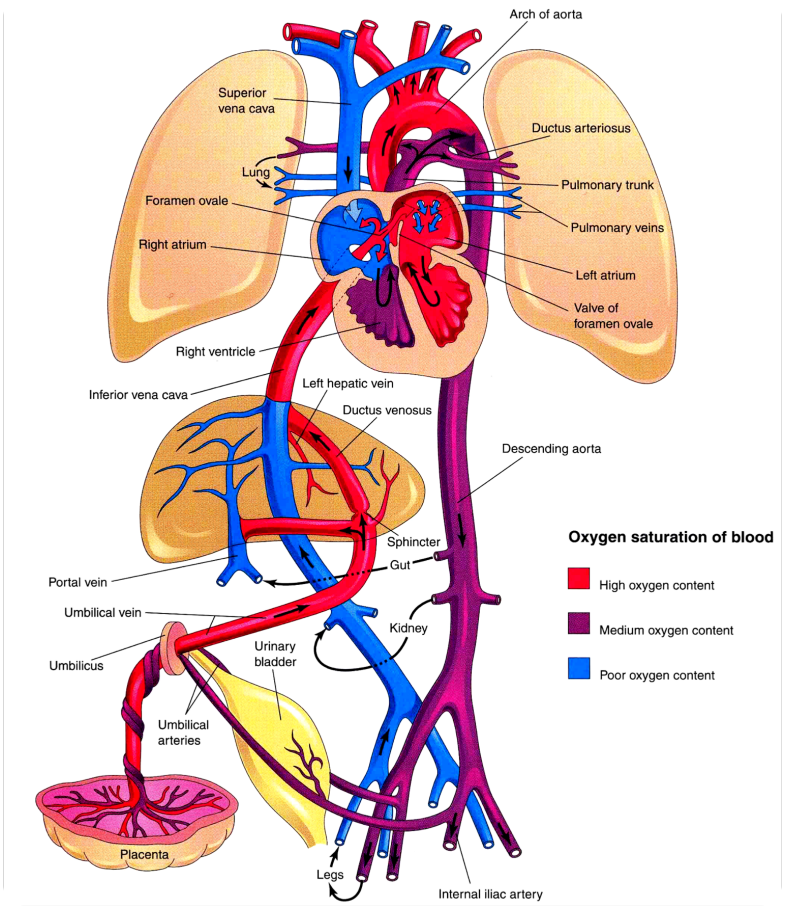


FIG. — Circulación fetal